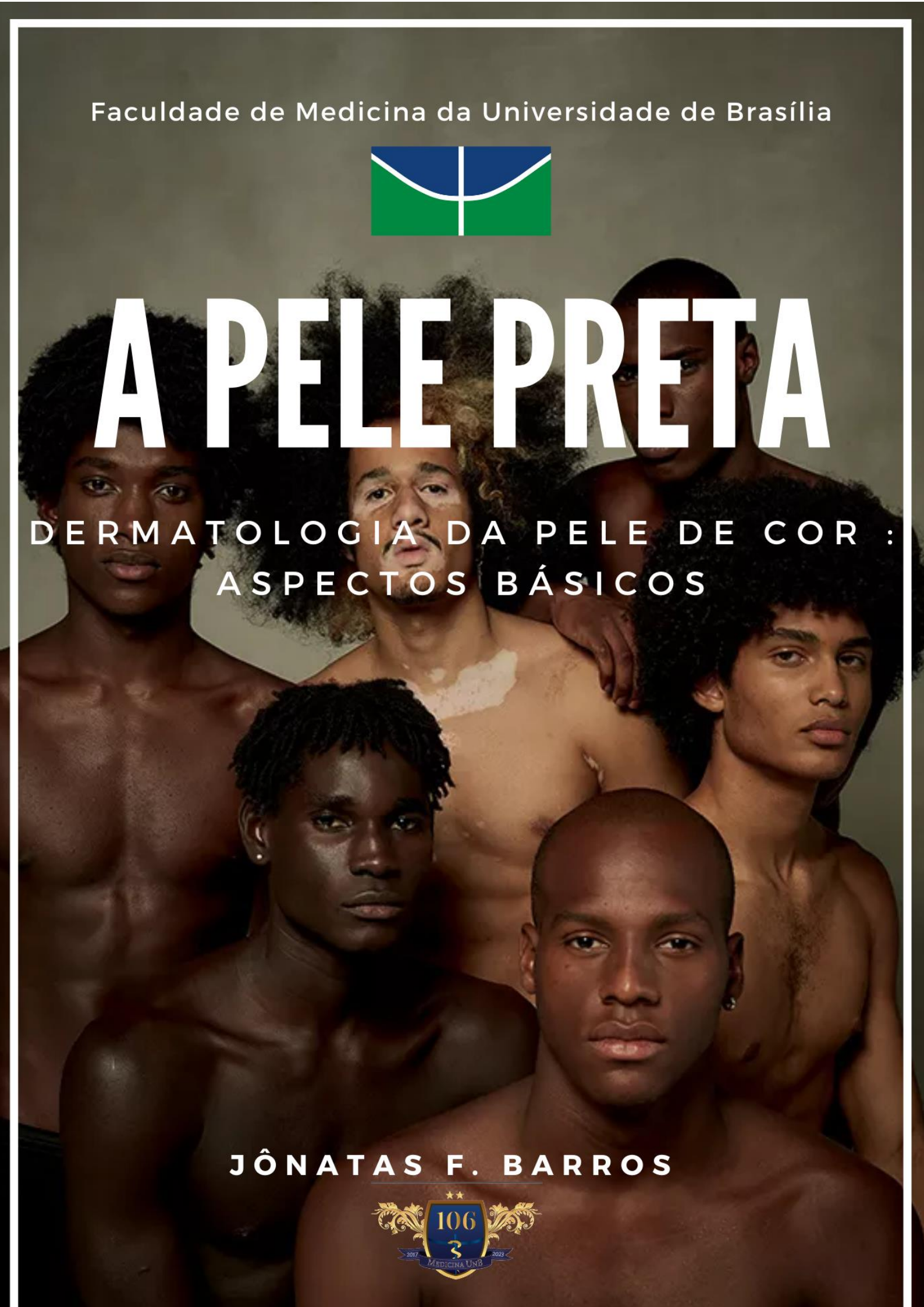
Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília

A PELE PRETA

DERMATOLOGIA DA PELE DE COR : ASPECTOS BÁSICOS



JÔNATAS F. BARROS

106

2017 2023

MEDICINA UNB



DERMATOLOGIA NEGRA

SUMÁRIO

1-DERMATOLOGIA GERAL 2

INTRODUÇÃO E DEFINIÇÕES 2
HISTOLOGIA E FISIOLOGIA 3
LESÕES CUTÂNEAS ELEMENTARES 5

2- PELE NEGRA 6

INTRODUÇÃO E DEFINIÇÕES 6
PARTICULARIDADES ESTRUTURAIS, BIOLÓGICAS E FUNCIONAIS DA PELE NEGRA 7
ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS DA PELE NEGRA 9
CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS DERMATOSES NA PELE NEGRA 11
ASPECTOS PARTICULARES DE DERMATOSES COMUNS 11
ALGUMAS DERMATOSES MAIS ESPECÍFICAS DA PELE NEGRA 14
ALGUMAS DERMATOSES POUCO FREQÜENTES NA PELE NEGRA 18
REFERENCIAS 19

1- DERMATOLOGIA GERAL

INTRODUÇÃO E DEFINIÇÕES

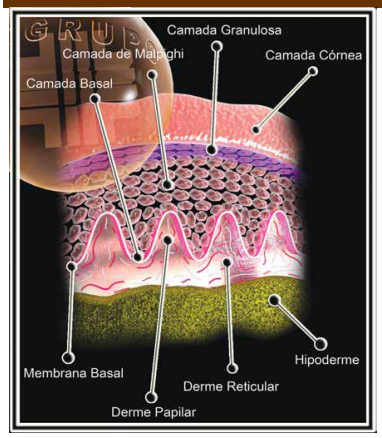
- A pele humana tem origem ectodérmica e mesodérmica, unidas por uma **junção dermoepidérmica**, muito irregular e repleta de projeções da epiderme para dentro da derme chamados **cones interpapilares**
- Abaixo da derme existe o panículo adiposo ou chamada também de hipoderme ou subcutâneo, rico em gordura
- Existem dois tipos de pele
    - A pele glabra é encontrada na palma das mãos e plantas, não possuindo folículo pilosos e nem glândulas sebáceas
        - Espessura maior com melhor diferenciação das camadas na epiderme
        - Sulcos e cristas que formam os dermatóglifos, responsáveis pelas impressões digitais

- Outro tipo de pele possui fâneros e glândulas sebáceas, com espessura variável

FUNÇÕES DA PELE

- **Proteção**: espessura e coesão entre os queratinócitos, aderidos fortemente à derme. A melanina e antioxidantes protegem contra a radiação
- **Termorregulação**: glândulas sudoríparas e vasodilatação cutânea
- **Resposta imunológica**: primeira linha de atuação da resposta inata e adaptativa
- **Barreira contra desidratação**
- **Sensação**
- **Excreções**: glândulas écrinas excreta água, eletrólitos, HCO3, ureia, metais pesados
- **Endocrinometabólica**: sítio de conversão periférica de hormônios sexuais e vitamina D

HISTOLOGIA E FISIOLOGIA



- A pele se divide em 3 camadas
  - Epiderme (endoderme)
  - Derme e subcutâneo (mesoderme)

EPIDERME

- Os queratinócitos compõem 80% da epiderme e são responsáveis pela composição de pelos, unhas e glândulas
- Formada por um epitélio pavimentoso estratificado, formado por queratinócitos que vão se maturando e diferenciando, gerando 4 camadas

CAMADA BASAL

- Camada mais profunda
- Formada por células colunares ancoradas à membrana basal
- Essas células encontram-se em intenso processo mitótico de queratinócitos
- A maturação ocorre com a transformação de células colunares em células achatadas e queratinizadas na camada córnea
  - Se macha Tunover celular epidérmico
  - Demora cerda de 52 a 75 dias
  - **Na psoríase, o turnover demora de 4 a 5 dias (doença hiperproliferativa)**



- Os hemidesmossomos aderem à célula da camada basal à membrana basal (lâmina lúcida)

CAMADA ESPINHOSA OU DE MALPIGHI

- Pontes intercelulares evidentes
  - Parecem processos espinhosos
  - Adesão entre os queratinócitos por desmossomos (integrinas + filamentos intermediários de queratina)
  - **Sua quebra gera bolhas (pênfigo e epidermite bolhosa)**
  - Os glicocálices servem como mecanismo de adesão intercelular

CAMADA GRANULOSA

- Grânulos de querato-hialina
  - Liberados e envolvem o queratinócito
  - Geram a corneificação
- Grânulos lamelares
  - Manto lipídico da pele
- Antes de atingir a superfície, os queratinócitos perdem o núcleo e se achatam, liberando substâncias de cimento celular e ganham maior resistência, graças às ligações cruzadas entre os filamentos de queratina e ativação da profilangrina em filangrina

CAMADA CÓRNEA

- Células fortemente ligadas por ponte de sulfeto e cerato-hialina
- Grânulos lipídicos cobrem as membranas celulares
- 98% de capacidade de retenção de água
  - Quase impermeável
- Conversão da luz solar em vitamina D
  - Camada lúcida: as células claras

CÉLULAS DA EPIDERME DE IMPORTÂNCIA

MELANÓCITOS:

- células ectodérmicas da crista neural
- síntese de grânulos (melanossomas) ricos em melanina
- Absorver radiação UV
- Unidade epidermomelanômica: união entre melanócito e queratinócitos
- O número de melanócitos não altera de uma raça para outra, mas a morfologia, tamanho e distribuição de malonossomos
- Estímulo da radiação UV e hormônios sexuais, mediadores inflamatórios e vitamina D3

CÉLULAS DE LANGERHANS

- Origem na MO
- Reconhecimento e apresentação de antígenos solúveis e haptenos aos linfócitos T

CÉLULA INDETERMINADA



- Células dendríticas
- Morena misteriosa

CÉLULAS DE MERKEL

- Grânulos osmiófilos
- Neurotransmissores
  - Liberados pela pressão
  - Receptores mecânicos

DERME

- Camada de tecido conjuntivo
  - Colágeno e Elastina
  - Material amorfo de macromoléculas retentoras de água (ácido hialurônico)
- Sistema vascular e nervoso da pele e anexos cutâneos
- Fibroblastos, Histiócitos, células dendríticas e mastócitos
- Células leucocitárias

DERME PAPILAR

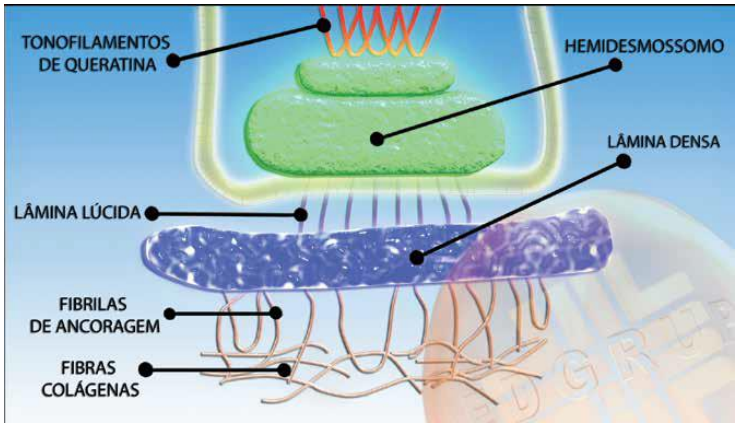
- Mais superficial
- Fibras colágenas finas e verticais
- Mais celularidade
- Derme reticular
- Mais profunda
- Feixes grossos de colágeno e horizontais

DERME ADVENTÍCIA

- Em torno de vasos e nervos
- Semelhante a derme papilar

JUNÇÃO DERMOEPIDÉRMICA

- Membrana basal de grande complexidade
- **Doenças bolhosas**
- Papilas dérmicas
  - Projeções da derme na epiderme
- Cones interpapilares
  - Projeções da epiderme na derme
- Orienta a orientação de crescimento de queratinócitos
- Emitir sinais para atividade mitótica
- Barreira a passagem de macromoléculas e células



- Hemidesmossomsos
  - Filamentos de queratina inserida nas placas hemidesmossômicas
  - A placa é rica em Antígeno do Penfigoide Bolhoso (PBAg1)
  - Antígeno de Penfigoide Bolhoso 2 (PBAg2)
  - **Pênfigo Bolhoso**
- Lâmina lúcida
  - Mais frágil
  - Passam as fibrilas de ancoragem
- Lâmina densa
  - Colágeno do tipo IV
  - Antígeno da epidermólise bolhosa adquirida (doença bolhosa)

INERVAÇÃO DA DERME

- **Corpúsculos de Meissner e Vater-Pacini**
  - **Tato e pressão, propriocepção**
- **Corpúsculo de Rufinni**
  - temperatura
- Dor, prurido e temperatura
  - Fibras amielínicas
- Variam com a intensidade do estímulo
- Sistema Autônomo
  - Adrenalina leva a vasoconstrição, músculos piloeretores e glândulas apócrinas
  - Colérgicas com glândulas écrinas
  - Glândulas sebáceas não são reguladas por inervação, são endócrinas inteiramente

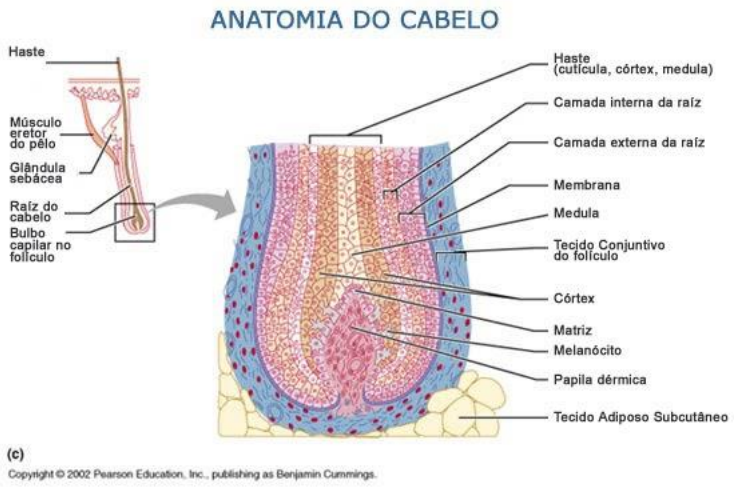
HIPODERME OU PANÍCULO ADIPOSO

- Abaixo da Derme Reticular
- Lóbulos de adipócitos por delimitação de septos de TC irrigado e inervado
- Isolante térmico e mobilidade
- Função endócrina
  - Conversão periférica de hormônios sexuais

ANEXOS CUTÂNEOS

FOLÍCULO PILOSO

- São todos formados na vida embrionária
- O folículo maduro é composto por uma haste pilosa, duas bainhas (foliculares internas e externas) e um bulbo germinativo
    - Infundíbulo
    - Istmo
    - Segmento inferior
- As células sofrem crescimento até chegar no canal folicular, onde compactam e desidratam
- A cor do pelo depende do melanossomo depositado



GLÂNDULA SEBÁCEA

- Glândulas exócrinas com ducto que desemboca no folículo piloso
- Células espumosas e holócrinas (descamam inteiramente)
- Sebo constituído por colesterol, ésteres graxos e TAG
- Atividade máxima na puberdade por hormônios androgênios

GLÂNDULAS SUDORÍPARA APÓCRINA

- Axilas, Genital e periareolar
- Secreção oleosa e inodora
- Metabolizada por uma flora bacteriana derivando odor

GLÂNDULA SUDORÍPARA ÉCRINA

- Sudorese e termorregulação
- Distribuição universal

APARELHO UNGUEAL

- Placas laminares de queratina nas falanges distais

LESÕES CUTÂNEAS ELEMENTARES



LESÕES PLANAS

- Alterações circunscritas da cor da pele, sem modificação da textura ou relevo

MANCHAS PIGMENTARES

- Relacionadas aos pigmentos endógenos (bilirrubina e caroteno) e exógenos (antimalárico, prata, clofozimina, amidarona, corantes)
- **Mácula** (<1cm de diâmetro) e **Mancha** (>1cm)
- **Hipercrômicas, Hipocrômicas e Acrômicas**
- Exemplos: neurofibratose, vitiligo, pitríase vesicolor

MANCHA VASCULOSSANGUÍNEAS

- Dividem-se em transitórias e permanentes

TRANSITÓRIOS

- **Rubor**
- **Cianose**
- **Figurado**: eritemas desenhados
    - Doença de Lyme
    - Eritema giratum rapens são paraneoplasias associada a neoplasia pulmonar
    - Eritema magirnatum são observados na febre reumática
- **Enantema**: eritema com acometimento na mucosa
- **Exantema**: **aparecimento súbito e com tendência a generalização**
    - Morbiliforme: eritema entremeado com áreas de pele sã
        - Rubéola, farmacodermia
    - Escarlatiniforme: difuso e uniforme
        - Escarlatina
- **Manchas anêmicas**: aumento da sensibilidade às catecolaminas, diminuindo o aporte sanguíneo à região

PERMANENTES

- **Manchas angiomatosas**
    - Aumento do números de capilares
    - Síndrome de Sturge-Weber
- **Telangiectasias**
    - Dilatação permanente de pequenos vasos
    - Insuficiência hepática
- **Púrpura**
    - Extravasamento de hemácias e não desaparece a digitopressão

- **Petéquias**
- **Equimoses**
- **Hematomas**

LESÕES ELEVADAS

- Pápula: menor que 1cm
- Placa: maior que 1 cm
- Tubérculo: consistência dura, elevada com mais de 1cm, que deixa cicatriz ao involuir
  - Doença granulomatosa: sarcoidose e hanseníase
- Nódulos: mais palpáveis que visível maior que 1 cm
- Tumoração: maior que 3 cm
  - Tofo gotoso
- Goma: nódulo que sofre evolução em fases
- Vegetação: crescimento exofítico pela hipertrofia das papilas dérmicas
  - Verrucosa
  - Condilomatosa

COLEÇÕES LÍQUIDAS

- Vesículas: conteúdo claro com menos de 1cm
  - Herpes: Múltiplas vesículas agrupadas em base eritematosa
- Bolha: vesículas com mais de 1cm
- Pústula: conteúdo purulento em até 1cm
  - Sépticas ou asséptica
  - Foliculares ou interfoliculares
- Abcesso: coleção purulenta, proeminente e circunscrita, flutuante, com sinais flogísticos

ALTERAÇÕES DE ESPESSURAS

- Ceratose: espessamento da epiderme
- Liquenificação: Aumento dos sulcos e saliências por atrito
- Infiltração: espessamento difuso por infiltrado inflamatório
  - Hanseníase
- Esclerose: endurecimento da pele por proliferação de colágeno ou subcutâneo
  - Esclerodermia
- Atrofia: diminuição da espessura

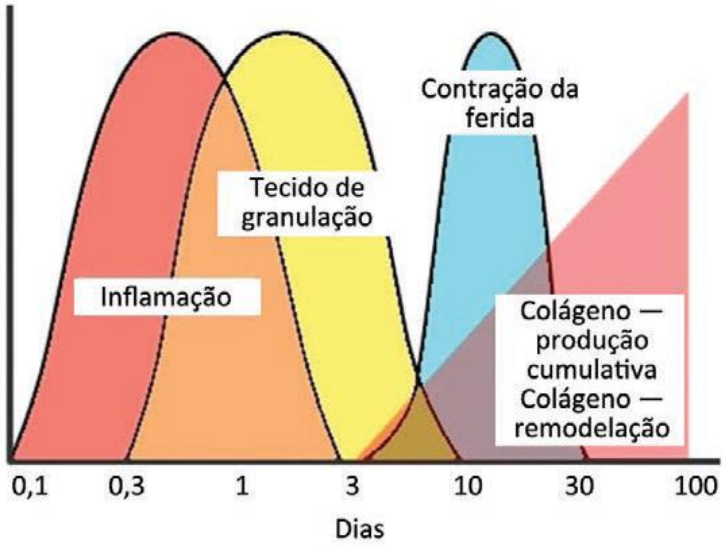
SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE

- Escoriação: lesão superficial linear traumática
- Fissura: linear e estreita
- Fístulas: trajeto linear sinuoso e profundo com eliminação de substâncias
- Erosão: acomete apenas a epiderme
- Exulceração: até a derme papilar
- Ulceração ou úlcera: acomete toda a derme e/ou hipoderme

LESÕES CADUCAS

- Escama: Lâminas epidérmicas secas pelo exagero de ceratina
- Crosta: ressecamento de exsudato
  - Serosa
  - Purulenta
  - Hemática
- Úlcera de decúbito: úlcera secundária à necrose

SEQUELAS



- Cicatriz: reparação conjuntiva e epitelial da pele traumatizada
  - Atrófica
  - Hipertrófica: acompanha a margem do insulto traumático. Crescimento rápido
    - Regiões de alta mobilidade
- Queloide: lesões que se prolonga além da margem
  - Crescimento lento
  - Regiões de baixa mobilidade
  - Recorrem no tratamento

2- PELE NEGRA

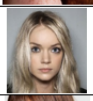
INTRODUÇÃO E DEFINIÇÕES

- O determinismo genético da pigmentação cutânea não é bem conhecido
  - Combinações alélicas de genes específicos dão origem a cores que variam do extremo "preta" ao extremo "branca", passando por tons intermediários
- A dermatologia utiliza sistemas de classificação para a cor da pele, mas nenhum pode ser padronizado para a "pele de cor
- O mais usado é o de Fitzpatrick, que define o fototipo

- Ele foi desenvolvido para definir a resposta de tipos diferentes de pele à luz ultravioleta solar, através de queimadura ou de bronzeamento
- Um sistema de classificação baseado na propensão da pele a se tornar hiperpigmentada por estímulo inflamatório e sustentar essa hiperpigmentação por período prolongado pode ser de valor, já que essa característica é exclusiva da pele pigmentada
- Esse sistema de classificação foi desenvolvido para categorizar a pele branca
- A pele escura abrange várias gradações de cores, subsequentemente, foi dividida nos fototipos IV, V e VI, que raramente ou nunca queimam pelo sol e bronzeiam facilmente

Quadro 2 - Classificação de Fitzpatrick modificada

FOTOTIPO SOMATÓRIO DOS PONTOS DA TABELA ABAIXO	I 0-7	II 8-16	III 17-25	IV 26-30	V OU VI >30
Pontuação	0	1	2	3	4
Cor dos olhos	Azul claro ou cinza	Azul ou verde	Mel, castanho claro	Castanho escuro	Marrom escuro
Cor natural cabelo	Vermelho avermelhado	Loiro	Loiro escuro, castanho	Marrom escuro claro	Preto
Cor da pele (áreas não expostas ao sol)	Avermelhado	Bem pálido	Pálido com bege	Marrom claro	Marrom escuro
Presença de sardas em áreas expostas ao sol	Vários	Muitos	Poucos	Incidentais	Nenhum
Exposição solar prolongada	Vermelhidão dor, bolhas e descamação	Bolhas seguidas de descamação	Queima, às vezes segue descamação	Às vezes queima muito	Nunca queima
Grau de bronzeamento	Quase nada ou nada	Bronzeado leve	Bronzeado razoável	Bronzeia muito fácil	Escurece bem rápido
Bronzeamento após várias horas de exposição solar	Nunca	Raramente	De vez em quando	Geralmente	Sempre
Sensibilidade da face ao Sol	Bem sensível	Sensível	Normal	Bem resistente	Nunca teve problemas
Última exposição (sol, mesa de bronzeamento ou cremes bronzeantes)	Mais que 3 meses atrás	2 a 3 meses atrás	1 a 2 meses atrás	Menos de 1 mês atrás	Menos de 2 semanas atrás
Freqüência de exposição solar na área de tratamento	Nunca	Raramente	De vez em quando	Geralmente	Sempre

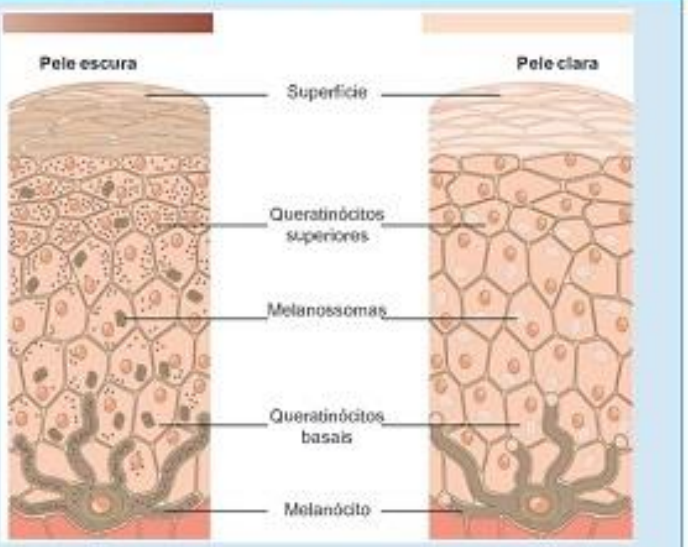
Fototipo	Aparência	Reação à exposição solar	Pigmentação imediata (dura 6-8 horas)	Pigmentação retardada (dura 10-14 dias)
I	Pele muito branca, cabelo loiro ou ruivo, olhos claros e frequentemente sardas 	Queima facilmente, nunca bronzeia	Nenhuma	Nenhuma
II	Pele branca, olhos claros, cabelo claro 	Queima facilmente, bronzeia muito pouco	Fraca	Mínima a fraca
III	Pele clara, olhos e cabelos de cor variável 	Queima um pouco e bronzeia gradualmente	Pouca	Baixa
IV	Pele moderadamente pigmentada a muito pigmentada 	Raramente queima e bronzeia com facilidade	Moderada	Moderada
V	Escura ou do Sudoeste Asiático 	Não queima e bronzeia	Intensa	Intensa
VI	Muito escura 	Bronzeia facilmente	Muito intensa	Intensa

PARTICULARIDADES ESTRUTURAIS, BIOLÓGICAS E FUNCIONAIS DA PELE NEGRA

EPIDERME

- A quantidade de melanina na epiderme é maior nos indivíduos negros, sem diferenças no número de melanócitos
  - Aquela se deve a variações no número, tamanho e agregação de melanossomas nos melanócitos e nos queratinócitos
  - Pele negra tem melanossomas grandes, não-agregados com número aumentado na camada basal e distribuídos por todas as camadas da epiderme
- Pele branca tem melanossomas pequenos e agregados alguns nas camadas basal e malpighiana, estando ausentes nas camadas superiores da epiderme
- O conteúdo de melanina confere, naturalmente, fator de proteção solar (FPS) de 13,4 à pele preta, sendo a camada malpighiana o principal local de filtração da radiação ultravioleta; nos brancos é a camada córnea
- O extrato córneo na pele negra contém mais camadas de células do que na pele branca, porém a espessura é igual em ambas, mostrando que é mais compacto na negra, provavelmente por maior coesão intercelular
- Não há consenso sobre as diferenças entre as raças na função de barreira exercida pela pele
  - Um estudo sugere diferenças na vulnerabilidade do extrato córneo associada à dinâmica das ceramidas
    - O extrato córneo da pele negra possui menos lipídeos, cujos níveis se correlacionam inversamente com a perda transepidérmica de água, maior em negros do que em brancos, e diretamente com o conteúdo de água, menor em negros
    - Inversamente, a exposição a irritantes tópicos (coaltar) mostrou maior vulnerabilidade do extrato córneo na pele branca, a qual desenvolve papulopústulas inflamatórias e desintegração folicular, enquanto a pele negra desenvolve hiperqueratose

Figura 2. Pigmentação da pele



A coloração relativa da pele depende da quantidade de melanina produzida pelos melanócitos na lâmina basal e distribuída ao longo dos queratinócitos da epiderme

Adaptada de https://opentextbc.ca/anatomyandphysiology/chapter/5-1-layers-of-the-skin/

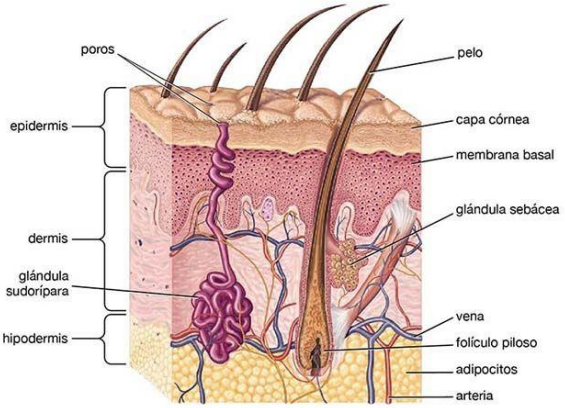
DERME

- Não há diferença na espessura da derme entre negros e brancos, mas parece haver em alguns aspectos celulares
- Os fibroblastos da pele negra são maiores, bi ou multinucleados, em maior número e hiperativos, o que, combinado à diminuição da atividade da colagenase, pode originar a formação de queloide, de incidência maior em negros
- Os feixes de fibras colágenas são menores e dispostos mais paralelamente à epiderme, notando-se muitas fibrilas colágenas e fragmentos de glicoproteínas no interstício dérmico
- Os macrófagos são maiores e mais numerosos, não havendo diferenças de origem racial nos mastócitos

GLÂNDULAS

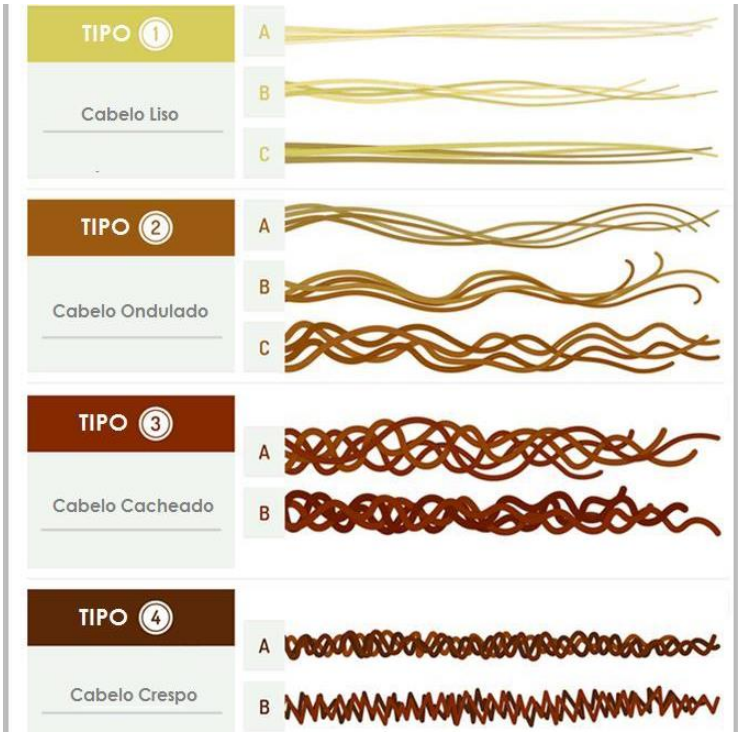
- Não há diferença no número de glândulas sudoríparas écrinas
    - Embora se verifique mais sudorese em brancos; as glândulas sudoríparas apócrinas são maiores, mais numerosas e produzem maior quantidade de secreção na pele negra
    - Há maior número de glândulas sudoríparas apócrino-écrinas na pele facial de mulheres negras;
- Não há diferença no número de glândulas sebáceas, mas essas são maiores e produzem maior quantidade de sebo na pele negra

FOLÍCULOS PILOSOS



- A densidade de cabelos e o número total de folículos terminais nos indivíduos negros são menores em comparação aos indivíduos de pele branca, mas as fibras possuem elementos estruturais e químicos comuns
- Há diferenças na aparência, na geometria, nas propriedades mecânicas e no conteúdo de água
- O denominado "cabelo encarapinhado" tem aparência crespa, irregularidades no diâmetro ao longo da haste e secção transversal elíptica
    - Os folículos pilosos são curvados, em forma de espiral
- O estudo ultraestrutura revela poucas fibras elásticas ancorantes para a derme nos folículos pilosos, o que pode ter implicação na gênese de certas alopecias
- O conteúdo de água e a resistência tênsil são menores, e por isso quebram facilmente, formam nós e fissuras longitudinais, sendo difíceis de pentear
- São mais pigmentados, os grânulos de melanina são maiores, e, apesar de apresentarem o mesmo tipo de queratina, possuem diferenças na composição dos aminoácidos, com deficiência de serina e treonina, e excesso de tirosina, fenilalanina e amônia





Para estudar a estrutura da pele: https://www.cosmeticsonline.com.br/artigo/405

ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS DA PELE NEGRA

DISCROMIAS

- A hiperpigmentação perioral é queixa frequente das mulheres negras.
    - A causa é desconhecida e parece não ser sequela de inflamação. Afeta a pele adjacente aos ângulos da boca



- A melanose da área malar é observada em indivíduos com mais de 50 anos
    - Não tem predileção por sexo, mas parece estar relacionada à atopia quando ocorre em mulheres jovens

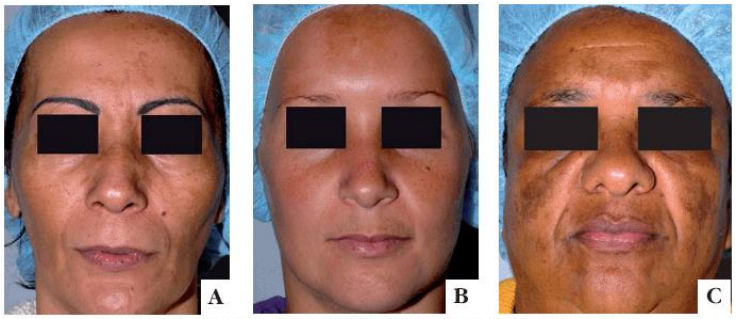


Figura 7: Fotos clínicas de pacientes com melasma, demonstrando as principais topografias acometidas. A. Glabelar, zigomático e nasal. B. Frontal e zigomático. C. Glabelar, zigomático, labial superior e mentoniano



- A hiperpigmentação palmoplantar é comum, e quanto mais pigmentada for a pele do indivíduo, maior a possibilidade de ocorrência
    - São máculas acastanhadas múltiplas que devem ser diferenciadas de lesões sifilíticas secundárias, as quais tendem ao monomorfismo e à localização nos arcos palmoplantares
- As linhas de Futcher ou de Voigt ocorrem em 25% dos indivíduos negros
    - São linhas pigmentares bem demarcadas, bilaterais, nos braços e nas pernas, separando a região anterolateral mais escura da região anteromedial mais clara
    - Correspondem ao nervo espinhal subjacente de um dermátomo
    - Podem surgir durante a gravidez, e a maioria está presente ao nascimento





- A hipopigmentação da linha média ocorre em percentual que varia de 30% a 40% dos indivíduos negros
    - Afeta mais homens, tornando-se menos visível com o avançar da idade

  - Parece ser de herança autossômica dominante
  - É faixa linear hipocrômica na região esternal, que pode estender-se até a linha alba ou à região infraclavicular
- A mancha mongólica ocorre em percentual que varia de 40% a 90% dos neonatos negros
  - Apresenta cor azul-acinzentada, geralmente é única e localiza-se na região lombossacral, podendo acometer outras regiões
  - Deve-se à presença de melanócitos na derme
  - São diagnósticos diferenciais os nevos e os hematomas
  - Costuma desaparecer em torno dos sete anos de idade e raramente persiste na adolescência
  - Pode coexistir com outras lesões cutâneas, tais como nevos e hemangiomas e, sendo extensa, deve ser pesquisada a associação com condições sistêmicas, especialmente os erros congênitos do metabolismo





- A hiperpigmentação da mucosa oral ocorre nas gengivas e, menos frequentemente, na mucosa jugal, no palato e língua
  - O grau de pigmentação da mucosa não se correlaciona com o da pele. Deve ser diferenciada de pigmentações causadas por drogas ou doenças sistêmica



- A melanoníquia ungueal longitudinal ocorre em cerca de 50% dos indivíduos negros, sendo a frequência e a intensidade da pigmentação relacionadas ao aumento da idade
  - Traumas ou irradiação solar podem ter papel etiológico
  - Origina-se de melanócitos da matriz
  - São faixas melanóticas longitudinais na lâmina ungueal, mais comuns nos dedos polegar e indicador, bilateralmente
  - Deve ser diferenciada de pigmentações causadas por drogas, doenças sistêmicas, nevos melanocíticos ou melanoma
  - Não se associa ao melanoma, mas são sinais de alerta a essa possibilidade largura superior a 3mm, pigmentação variável, aumento rápido no tamanho, presença do sinal de Hutchinson e de lesões solitárias, particularmente no polegar



- Pápulas peroladas penianas
  - Incidem em 14% a 48% dos homens na idade póspuberal, mais comumente na segunda ou na terceira década de vida, e em homens negros
  - Caracterizam-se por lesões assintomáticas, branco-peroladas, em forma de cúpula, medindo 1mm a 4 mm, intimamente agrupadas, localizadas na glande do pênis
  - São comumente encontradas em fileira única ou mesmo dupla, distribuídas, circunferencialmente, no sulco ou na região coronal

LEUCODERME ORAL

- Ocorre em 90% dos indivíduos negros, sem predileção por sexo
- Embora seja considerado alteração fisiológica, tem sido sugerido que a irritação local pelo fumo e a higiene oral precária estejam implicados em seu surgimento
- São placas brancas, não descamativas, localizadas na mucosa jugal
- Deve ser diferenciado das lesões brancas da mucosa oral, tais como a leucoplasia, o líquen plano, o nevo esponjoso e a candidíase



LINHAS PEROLADAS JUSTACLAVICULARES

- A pele da região clavicular pode apresentar aspecto linear, mais comumente visto na pele escura, provavelmente pela melhor visibilidade dos óstios foliculares

CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS DERMATOSES NA PELE NEGRA

- No geral, as dermatoses se manifestam de modo similar, mas com padrões exagerados de reações, incluindo labilidade pigmenta (hiperpigmentação ou hipopigmentação), resposta folicular e resposta mesenquimal (fibroblástica ou granulomatosa)
- O reconhecimento das lesões elementares é dificultado pela hiperpigmentação cutânea, que causa modificações notáveis na cor
- Muitas lesões são quase imperceptíveis, outras, especialmente as acrômicas, muito evidentes, causando grande prejuízo estético
- O eritema é de difícil reconhecimento na pele intensamente pigmentada, por exemplo, o eritema discreto não é percebido, ou um tom francamente violáceo mostra-se azulado ou cor de ardósia



- A maioria das dermatoses induz à hiperpigmentação ou à hipopigmentação pós-inflamatória
- Cabelo crespo
  - Faz-se necessário o uso de produtos oleosos, que causam enfermidades, como um tipo de acne por contactantes comedogênicos e as foliculites, além de alopecias provocadas pela manipulação excessiva dos cabelos
  - O folículo curvado tem papel central na etiologia de condições como a pseudofoliculite da barba e a acne queloideana da nuca

ASPECTOS PARTICULARES DE DERMATOSES COMUNS

ALTERAÇÕES PIGMENTARES

- Grande parte dos distúrbios vistos na pele negra é de origem pigmentar, representando as alterações mais óbvias e angustiantes nesse grupo étnico, sendo em geral muito evidentes e difíceis de tratar
- Destacam-se o melasma, a hiperpigmentação e hipopigmentação pós-inflamatória, a pitiríase alba, a hipomelanose gutata idiopática, o vitiligo e as acromias secundárias (a doenças, a esfoliações químicas, à crioterapia ou à corticoterapia intralesional)



Figura 9. Manchas hipopigmentadas confluentes, mal definidas, não descamativas, localizadas no tronco

ACNE

- A incidência da acne em indivíduos de pele negra é alta, apesar de ser pouco menor do que a observada na pele branca
- Parece haver maior densidade de Propionibacterium acnes
- As lesões nódulo-císticas são menos frequentes, mas mesmo lesões sem inflamação clínica, como as comedoneanas, têm alto grau de inflamação histológica, o que pode explicar o fato de deixarem intensa hiperpigmentação pós-inflamatória
- Cicatrizes queloideanas são sequelas frequentes e não recorrentes no tórax, no dorso e na linha mandibular
- Há um tipo frequente de acne por contactantes, que consiste em comedões na área frontal e temporal, resultante da ação de produtos gordurosos nos cabelos
- O maior desafio em tratar a acne na pele pigmentada com agentes tópicos é a possível dermatite de contato irritativa que causa hiperpigmentação pós inflamatória, sendo necessário selecionar agentes menos irritantes adotar estratégias que melhorem a tolerabilidade e orientar o uso de fotoprotetores não comedogênicos
- Antibióticos tópicos e sistêmicos são úteis sempre, pois diminuem a inflamação, ficando reservada a isotretinoína para os casos mais graves



3. Comedões, manchas hipercrômicas e cicatrizes na face.



Figura 25. Cicatrizes queloideanas em lesões prévias de acne.

PSORÍASE

- Menos comum nos indivíduos negros, tem distribuição clássica e lesões descamativas, com hipocromia ao redor, às vezes assumindo aspecto violáceo liquenóide ou eczematoso crônico
- Pode causar hiperpigmentação pós-inflamatória
- O prurido é usual
- As formas pustulosas e as ungueais são raras



Figura 35. Placas hiperceratósicas isolada, de distribuição simétrica,



Figura 36. Placas eritematodescamativas, de aspecto eczematoso, acometendo a superfície dorsal e palmar dos quirodáctilos, acompanhadas de edema das articulações interfalangeanas.

PITIRÍASE RÓSEA

- As lesões de pitiríase rósea nos negros são acinzentadas, mais pruriginosas, sendo comum se estenderem para a face, abdômen inferior e extremidades
- Há variantes papular ou papulovesicular, com descamação intensa
- O índice de recidiva é de cerca de 6% nos indivíduos negros, duas vezes maior do que nos indivíduos brancos



Figura 33. Múltiplas pápulas e placas, algumas coalescentes, bem delimitadas, descamativas, com ligeiro eritema, localizadas na região abdominal.

LÍQUEN PLANO

- Frequente na pele negra, suas lesões são brilhantes, escuras ou acinzentadas, sendo as formas anulares mais encontradas nessa cor de pele

- A hiperpigmentação residual é intensa e persistente
- Raramente os negros apresentam lesão oral
- Pode haver associação com líquen nítido, o qual não tem predileção racial



Figura 34. Pápulas e placas brilhantes, acinzentadas, algumas lineares, localizadas difusamente no tronco e no membro superior

ECZEMAS

- Há ausência de eritema perceptível e evolução rápida para discromias
- As formas agudas, com vesiculação e exsudação, são mais comuns nos indivíduos brancos; nos negros há mais alterações pigmentares e liquenificação





Figura 28. Pápulas foliculares e placas descamativas, de distribuição simétrica, nas regiões extensoras dos antebraços.

- A dermatite atópica evolui com lesões hiperpigmentadas ou hipopigmentadas
- Nas crianças há uma variante papulofolicular
- O eczema numular caracteriza-se por lesões numulares com hiperpigmentação intensa e persistente
- Quanto à dermatite de contato irritativa há controvérsias no diferencial racial da irritabilidade da pele
    - Estudos iniciais, baseados na observação do eritema, mostraram menor susceptibilidade da pele negra a substâncias irritantes, requerendo exposição prolongada para desenvolver a dermatite de contato irritativa
    - Estudos posteriores, usando parâmetros mais objetivos, mostraram maior sensibilidade da pele Negra*a, devida à barreira comprometida, à diminuição do fluxo sanguíneo cutâneo e à menor reatividade vascular
    - Na dermatite de contato alérgica, as áreas mais afetadas, como nos indivíduos brancos, são mãos e face
    - A interpretação do teste alérgico de contato é prejudicada pela difícil percepção do eritema
    - A capacidade em montar resposta imunológica aos antígenos é igual nas duas raças, estando as diferenças relacionadas às exposições, sendo mais responsabilizadas as práticas culturais do que fatores genéticos ou biológicos

SARCOIDOSE

- É encontrada 10 vezes mais em negros do que em brancos, com prognóstico pior e maior comprometimento sistêmico
- Há grande polimorfismo das lesões; pápulas e máculas hipopigmentadas ou psoriasiformes são mais comuns, enquanto o lúpus pérnio é mais raro. Lesões anulares, ictiosiformes, ulcerativas e tumorais são quase exclusivas dessa população



Figura 32. Pápulas e placas lisas e brilhantes distribuídas simetricamente nas regiões palpebrais

SÍFILIS

- Enquanto a sifílide macular é mais comum em brancos, formas foliculares, papulosas e pustulosas o são em negros, sendo a forma anular perioral quase exclusiva deste último grupo
- Lesões hiperpigmentadas palmoplantares, apesar de serem monomorfas e comprometerem a superfície medioplantar, devem ser diferenciadas da hiperpigmentação normal

- A alopecia do secundarismo é mais comum em negros, assim como o condiloma plano e as lesões do tipo goma



Figura 38. Placas anulares, com centro hipercrômico e bordas ligeiramente eritematosas, de distribuição perioral.



Figura 39. Lesões hiperceratóticas e hiperpigmentadas, monomorfas, comprometendo a superfície palmar

MICOSES SUPERFICIAIS

- Tinea capitis
  - As espécies de fungos infectantes mais prevalentes sofrem variações com o tempo, com o país em questão e mesmo as regiões de um mesmo país, a depender de fatores ambientais e étnicos, nível socioeconômico e densidade populacional
    - O Trichophyton tonsurans nos estados das regiões Norte e Nordeste e do Microsporum canis nos estados do Sul e Sudeste, sendo maior a prevalência em crianças
  - Nos adultos, estudos epidemiológicos realizados em outros países mostram que a incidência da tinea capitis é maior em indivíduos negros, particularmente do sexo feminino
  - Casos de tinea capitis em adultos negros causados pelas espécies de Microsporum são raros, sendo as espécies de Trichophyton, principalmente o Trichophyton tonsurans, os agentes etiológicos mais comuns
    - Uma razão possível para a baixa incidência de casos de tinea capitis causados pelas espécies Microsporum no adulto é a maior produção de sebo no couro cabeludo, pois o conteúdo rico em triglicérides exerce ação fungistática contra as infecções ectotrix por Microsporum
    - Entretanto, o sebo não previne as infecções endotrix causadas pelas espécies de Trichophyton
  - Alopecia, descamação semelhante à da dermatite seborréica e alterações inflamatórias são as manifestações clínicas observadas nas infecções por Trichophyton tonsurans



Figura 41. Mancha hipercrômica, com descamação predominantemente nas bordas, bem delimitada, na região inguinocrural.

- A pitiríase versicolor
  - Placas descamativas hiperpigmentadas ou hipopigmentadas, ocasionalmente com lesões foliculares, atingindo frequentemente a face, poupando o tronco e confundindo-se com dermatite seborréica

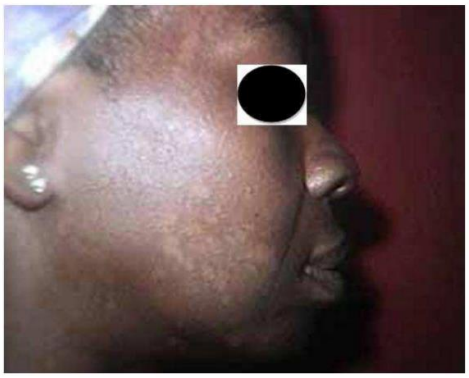


Figura 40. Manchas hipocrômicas lenticulares, descamativas, distribuídas na face e no pescoço.

ALGUMAS DERMATOSES MAIS ESPECÍFICAS DA PELE NEGRA

HIPERPIGMENTAÇÃO E HIPOPIGMENTAÇÃO PÓS-INFLAMATÓRIA

- Surgem após a resolução de lesões inflamatórias, especialmente as do tipo papuloescamosa e vesicobolhosa, devido à labilidade da resposta dos melanócitos à irritação ou à inflamação
- A patogênese é desconhecida, mas a liberação de certos mediadores químicos e citocinas parece ter algum papel
  - Cada doença libera mediadores específicos, responsáveis pelo aumento ou diminuição da função melanogênica do melanócito
  - Os mediadores inflamatórios leucotrieno B4, prostaglandinas D2 e E2, endotelinas, interleucinas 1 e 6, e fator - alfa de necrose

tumoral aumentam a melanogênese; o leucotrieno C4 a diminui

- A hiperpigmentação é sequela comum de acne vulgar, líquen plano, psoríase, reações de fotossensibilidade, pitiríase rósea, micose fungóide, eritema pigmentar fixo, eczemas, lúpus eritematoso subagudo e agudo, rosácea, traumas, queimaduras, entre outras condições
- A hipopigmentação mais comumente é consequência de dermatite seborréica, pitiríase alba, dermatite de contato, dermatite atópica, sarcoidose, líquen estriado, sífilis secundária, pitiríase versicolor, dermatite das fraldas, hipomelanose gutata idiopática, lúpus eritematoso discóide, queimaduras, hanseníase, herpes-zóster entre outras manifestações
- O tratamento é difícil e lento, sendo fundamental tratar a doença inflamatória que originou o distúrbio pigmenta
- Camuflagem e fotoprotetores são úteis. Para a hiperpigmentação, utiliza-se a hidroquinona, isolada ou associada aos corticoides e à tretinoína, esfoliações químicas superficiais são úteis, mas podem causar hiperpigmentação ou hipopigmentação pós-inflamatória
    - Atualmente, vários tipos de laser têm sido empregados, mas sem resultados satisfatórios
- As opções para a hipopigmentação incluem os corticosteroides e os psoralenos associados à luz ultravioleta A

PTIRÍASE ALBA

- Mais comumente relatada em crianças de pele negra, o que pode ser devido à melhor visualização das lesões pelo maior contraste com a pele sã
- As lesões iniciais são pápulas descamativas, pouco perceptíveis, que evoluem para manchas hipocrômicas bem visíveis, acometendo a face, o pescoço e os braços, e resistentes ao tratamento



Figura 10. Manchas hipocrômicas, mal delimitadas, pouco descamativas, acometendo a face.

DERMATOSE PAPULOSE NEGRA

- Inicia-se na adolescência; acomete entre 35% e 77% dos negros, e 50% deles têm história familiar. Acomete mais as mulheres, com pico na sexta década da vida
- São pápulas diminutas pigmentadas, sésseis ou pedunculadas, localizadas na face, no pescoço e no dorso
- Histologicamente são ceratoses seborréicas acantóticas, com pigmentação proeminente
- As opções terapêuticas são a eletrocoagulação, os cáusticos, o laser, a excisão cirúrgica e a crioterapia



Figura 13. Múltiplas pápulas pequenas, hiperpigmentadas, localizadas na face.

QUELOIDE

- De três a 18 vezes menos frequente na pele branca do que na pele negra, desenvolve-se após injúrias cutâneas por interação entre fibroblastos e citocinas, que facilitam a produção de colágeno e inibem a degradação de componentes da matriz extracelular

- É observado em grupos étnicos que usam sinais tribais, após colocação de brincos, em cicatrizes de vacinação com BCG e contra a varíola
- Manifesta-se por nódulo firme, às vezes pruriginoso, causando danos estético
- Os locais de predileção incluem o tórax, os lóbulos das orelhas e os ombros
- Pode ser confundido com cicatriz hipertrófica
- A crioterapia, a injeção intralesional de corticosteroides, a irradiação após excisão cirúrgica, as placas ou o gel de silicone, a loção de minoxidil, o laser, a radiação tipo UVA-1, o 5-fluorouracil e o interferon gama são terapêuticas usadas



Figura 12. Placas e nódulos brilhantes, endurecidos, ultrapassando os limites da ferida original

ÚLCERAS DA PERNA DA ANEMIA FALCIFORME

- A anemia falciforme é mais comum em negros e é rara abaixo dos 15 anos
- As úlceras dolorosas nas pernas, localizadas próximo aos maléolos, são as lesões cutâneas mais encontradas e ocorrem por oclusão vascular, infecção ou trauma
- O tratamento inclui antibióticos e cicatrizantes tópicos, a ingestão de ácido fólico e dieta balanceada



PSEUDOACANTOSE NIGRICANTE

- Comum entre indivíduos negros, lembra a acantose nigricante, tendo a fricção papel etiológico importante
- Ocorre escurecimento das faces mediais das coxas e das axilas além do pescoço, sendo comum a concomitância de acrocórdons e de obesidade
- Nas regiões inguinocrurais é frequente a presença de fungos



Figura 15. Espessamento aveludado da pele e hiperpigmentação na região cervical.

ENFERMIDADES DO CABELO E DO COURO CABELUDO

- As propriedades intrínsecas do "cabelo encarapinhado", os cuidados e as práticas culturais tornam as enfermidades do cabelo e do couro cabeludo mais usuais na população negra
    - As queixas incluem cabelos quebradiços, prurido, descamação, foliculites e alopecias
- A dermatite seborréica é processo crônico recorrente na população negra, podendo interferir em outros processos
    - O uso rotineiro de xampus antiseborréicos e de alisantes químicos ou térmicos seca a haste do cabelo, causando fragilidade
    - Além do mais, a tentativa de camuflar a descamação do couro cabeludo com emolientes pode causar dermatite de contato irritativa
    - São recomendados condicionadores e xampus anti-seborréicos hidratantes



Figura 16. Placa ligeiramente eritematosa com descamação espessa no couro cabeludo.

- A pseudofoliculite da barba (PFB)

- Alta prevalência em negros, de 45% a 83%, sobretudo nos homens entre 14 e 25 anos
- As mulheres são afetadas no climatério, as hirsutas com menos idade
- É inflamação causada pela estrutura do pelo e pela direção de seu crescimento, que curva para baixo e penetra na epiderme (penetração extrafolicular) ou cresce dentro do folículo, perfura sua parede e penetra na derme (penetração transfolicular)
- Acomete a face e o pescoço, mas processo similar ocorre em certas áreas pilosas (no couro cabeludo, na axila, no púbis e nas pernas) de indivíduos que depilam essas regiões
- São lesões tipo papulopústulas foliculares, eritematosas ou hiperpigmentadas, em que o pelo pode ser visto como sulco linear, devido ao crescimento paralelo
- As pústulas podem ser secundárias à infecção, geralmente pelo Staphylococcus epidermidis
- . É possível a ocorrência de hiperpigmentação pós-inflamatória e queloides
- O diagnóstico diferencial inclui foliculite bacteriana ou traumática, acne vulgar, dermatofitose, impetigo e pápulas sarcoídicas
- O exame histopatológico mostra invaginação da epiderme, infiltrado inflamatório neutrofílico, microabscessos, granulomas do tipo corpo estranho e fibrose
- A prevenção consiste em interromper a prática de se barbear, com lâminas manuais, ou então utilizar barbeador elétrico ou cremes depilatórios; o pelo é liberado em algumas semanas, por tensão natural ou massagens com água morna, esponja e sabonete antibacteriano
- O creme de eflornithine hydrochloride a 13.9% (Vaniqa®) inibe seu crescimento
- Os emolientes, a hidrocortisona 1% ou a ureia 10% diminuem a irritação após a depilação, e o emprego de antimicrobianos tópicos diminui a flora bacteriana normal, que é fator agravante à inflamação
- Os retinóides, o ácido glicólico e o ácido salicílico, por uso tópico ou em esfoliações, agem como queratolíticos e clareadores
- A utilização sistêmica de antibióticos, corticosteroides ou isotretinoína pode ser opção nos casos mais graves
- A cura é a destruição do pelo por eletrólise, laser ou remoção cirúrgica dos bulbos

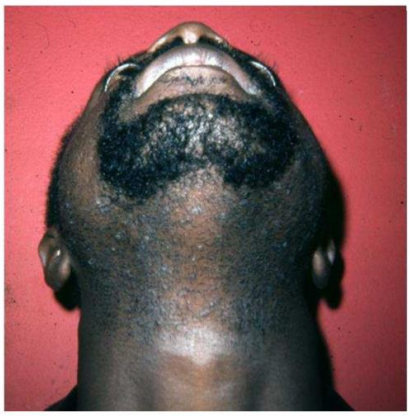


Figura 11. Pápulas e pústulas foliculares nos pelos da barba

- A foliculite dissecante do couro cabeludo é quase exclusiva de indivíduos negros, afetando homens jovens
  - Possível causa é a oclusão folicular e a reação granulomatosa à queratina
  - Nódulos e abscessos dolorosos localizam-se no vértice e na região occipital
  - A alopecia cicatricial e o queloide são sequelas previsíveis
  - O principal diagnóstico diferencial é com o quérion, e trata-se com o emprego sistêmico de corticosteroide, dapsona ou antibióticos
  - Zinco e ácido retinóico parecem exercer efeitos por diminuir a ceratinização folicular.
  - Os casos mais graves podem requerer drenagem, excisão cirúrgica ou radioterapia

ALOPECIAS

- A alopecia de tração e a síndrome de degeneração folicular, atribuídas a penteados (tranças apertadas, rabos-de-cavalo, adição de cabelo artificial ou adornos) ou a produtos e equipamentos, como alisantes químicos, secadores, processos térmicos, rolos e tintura
  - A alopecia de tração ocorre geralmente em mulheres negras, na linha frontal e parietotemporal
  - Relaciona-se à tensão prolongada e à escassez de fibras elásticas que ancoram os folículos pilosos na derme e produzem alopecias irreversíveis



Figura 18. Área de alopecia na linha frontal e parietotemporal.

- A síndrome da degeneração folicular ou alopecia cicatricial centrífuga ocorre no vértice e na região mediana do couro cabeludo, poupando a linha frontal. Piora progressivamente
    - Observa-se diminuição ou ausência das aberturas foliculares no couro cabeludo, que adquire aspecto brilhante
    - A histopatologia mostra inflamação nos folículos pilosos
    - Além da redução da inflamação causada pela dermatite seborréica, se presente, o tratamento tópico inclui o uso do minoxidil, de vitaminas, da ablação a laser, de antibióticos, de antifúngicos e de corticosteroides
    - Nos casos graves, drogas sistêmicas, tais como os corticosteroides, a dapsona, a hidroxicloroquina, a isotretinoína, a talidomida e o metotrexato, podem ser empregadas

ALGUMAS DERMATOSES POUCO FREQÜENTES NA PELE NEGRA

FOTOENVELHECIMENTO

- O conteúdo de melanina e o padrão de dispersão dos melanossomas ocasionam envelhecimento cutâneo mais tardio em indivíduos negros que costumam ter pele mais firme e mais lisa do que a de indivíduos brancos da mesma idade
- Os sinais de fotodano na pele mais pigmentada são a hiperpigmentação, a despigmentação, os lentigos e as ceratoses seborréicas, sendo o enrugamento aspecto tardio

FOTODERMATOSES

- Na pele negra não se observa o eritema nas fotodermatoses
- A queilite, tanto aguda quanto crônica, é sinal da Fotossensibilidade
- Há susceptibilidade menor às reações de fotossensibilidade a drogas e às reações fototóxicas; as reações fotoalérgicas são mais graves
- LES
    - As lesões discoides atróficas podem permitir a expressão do eritema e são mais desfigurantes do que as observadas na pele branca; as lesões subagudas e as agudas são hiperpigmentadas





NEOPLASIAS CUTÂNEAS

- O câncer da pele é menos comum em indivíduos negros, pois o maior conteúdo de melanina e o padrão de dispersão dos melanossomas são fatores de proteção para os efeitos carcinogênicos da luz solar
    - A proporção de câncer nos indivíduos negros foi de 5% (1,6% nos pretos e 3,4% nos pardos) contra 3,2% nos amarelos e 12,7% nos brancos
    - Com relação ao melanoma, a heterogeneidade dos tipos de pele da população brasileira torna sua epidemiologia variável, de acordo com a região estudada
- A radiação solar ultravioleta não é fator relevante para seu aparecimento, exceto no caso do carcinoma basocelular (CBC), que se desenvolve mais em áreas expostas ao sol; a ocorrência do carcinoma espinocelular (CEC) e do melanoma é maior nas áreas não fotoexpostas
    - Os índices de morbidade e mortalidade são maiores em indivíduos negros.
- O CEC é o mais frequente, representando 30% dos cânceres em negros
    - São fatores de risco os processos crônicos cicatriciais, a inflamação crônica, o albinismo, as verrugas virais, a epidermodisplasia verruciforme, a imunodepressão e os carcinógenos químicos, tais como o arsênico e o coaltar



Figura 43. Massa vegetante acometendo e destruindo a glande.



Figura 44. Lesão úlcero-vegetante, em cicatriz prévia de queimadura, na região do joelho esquerdo, se estendendo para a perna e coxa.

- O CBC é o segundo câncer cutâneo em frequência na pele negra
    - Apenas cerca de 1,8% dos casos de CBC ocorrem em indivíduos negros, sendo característica clínica frequente das lesões a pigmentação, presente em 50% dos casos

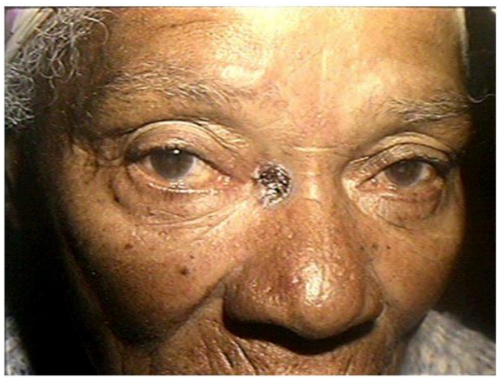


Figura 42. Lesão pigmentada, bem delimitada, com 1 cm, no canto do olho direito.

- O melanoma é o terceiro, representando de 1% a 8% do total dos cânceres cutâneos na população negra
    - É menos pigmentado e geralmente de localização mucosa ou acral (nas palmas, nas plantas e no leito subungueal)
    - Fatores de risco incluem albinismo, cicatrizes de queimadura, radioterapia, traumas, imunodepressão e lesões pigmentadas preexistentes (especialmente nas regiões acral e mucosa)
    - A história familiar não parece ser fator predisponente
    - As causas possíveis para o prognóstico pior incluem a demora no diagnóstico, a presença frequente de lesões primárias já mais espessas e os tumores acrais intrinsecamente mais agressivos



Figura 45. Pigmentação acometendo o leito ungueal e a unha do hálux, infiltrando tecidos adjacentes.

- Levando-se em conta grupos sociais diferentes, um estudo verificou que a frequência de melanoma na casuística assistencial (maioria da população brasileira) é significativamente maior em pacientes não brancos, em faixa etária mais elevada, com percentagem alta de melanoma acrolentiginoso, enquanto na casuística da clínica privada a doença predomina em indivíduos brancos, em faixa etária não elevada, com pequena percentagem de melanoma acrolentiginoso

REFERENCIAS

ALCHORNE, Mauricio Mota de Avelar; ABREU, Marilda Aparecida Milanez Morgado de. Dermatologia na pele negra. An. Bras. Dermatol., Rio de Janeiro, v. 83, n. 1, p. 7-20, Feb. 2008 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-05962008000100002&lng=en&nrm=iso>. access on 16 Dec. 2020. http://dx.doi.org/10.1590/S0365-05962008000100002

https://antoniorondonlugo.com/wp-content/uploads/2010/05/135-Aspectos-dermatologicos-na-pele-negra.pdf